Portfolio Business Analyst

MediTrack v2 — Refonte du parcours d'engagement d'une application de suivi de traitement chronique

---

Projet fictif réalisé dans le cadre d'une préparation au métier de Business Analyst
Document de travail — à reformuler et enrichir avant intégration finale au portfolio

1. Cadrage du projet

Persona principal

Léa, 34 ans, atteinte de la maladie de Crohn. Traitement de fond quotidien et injections bihebdomadaires. A téléchargé l'application après une poussée inflammatoire sévère, motivée à être plus rigoureuse dans son suivi. Après environ trois semaines d'usage assidu, sa fréquence de connexion chute fortement : elle continue de prendre son traitement, mais arrête de le renseigner dans l'application.

Problématique

Comment réduire le taux d'abandon de suivi chez les patients en traitement chronique de longue durée, au-delà des 4 à 6 premières semaines d'usage ?

Hypothèse de départ

L'application est conçue autour d'une logique « nouveau traitement, nouvelle motivation » (rappels, notifications), mais elle ne s'adapte pas quand le traitement devient une routine installée sur plusieurs mois ou années. La motivation extrinsèque s'essouffle, sans que rien ne prenne le relais.

Objectifs mesurables

- Réduire le taux de désengagement observé à 6 semaines
- Augmenter la rétention d'usage à 6 mois
- Maintenir un usage léger mais régulier, plutôt qu'un usage intensif ponctuel

2. Benchmark concurrentiel

Critère	Medisafe (référence médicale)	Strava (référence hors-secteur)
Mécanisme d'engagement	Rappels et alarmes persistants, suivi de mesures de santé	Preuve sociale : kudos, classements, défis entre amis
Logique de motivation	Extrinsèque et individuelle	Sociale et communautaire
Rôle de l'entourage	Alerté uniquement en cas d'oubli (logique d'échec)	Célèbre chaque activité réussie (logique de réussite)
Limite identifiée	Peu de mécanisme pour maintenir la motivation une fois la routine installée	Peut créer une pression sociale ou une comparaison excessive

Observations issues de tests réels (Medisafe)

- Aucun compte requis pour démarrer — bonne réduction de friction à l'onboarding
- Fréquence, heure et durée de traitement finement paramétrables, avec dates de début/fin
- Rappel de renouvellement basé sur le stock restant de médicaments
- Modification du dosage possible (pour une dose ou pour toutes les doses futures), mais sans historique consultable des changements passés
- Export d'un rapport par e-mail au format CSV brut, peu exploitable par un tiers (médecin ou aidant)
- Interface fonctionnelle mais basique, non personnalisable — peu propice à l'appropriation sur la durée

Insight clé : Medisafe résout bien le problème « ne pas oublier », mais pas le problème « rester motivé sur la durée ». Strava montre qu'une reconnaissance sociale peut prendre le relais d'une motivation individuelle qui

s'essouffle — à condition d'éviter toute logique de compétition ou de comparaison de performance, sensible dans un contexte de santé.

3. Recueil de besoins

Guide d'entretien (Léa)

- Comment gérais-tu ton traitement avant de télécharger l'application ?
- Raconte-moi hier : comment ça s'est passé pour ta prise du soir ?
- Qui ou quoi t'aide au quotidien à gérer ton traitement ?
- Comment communiques-tu ton avancement avec ton médecin ?
- Te souviens-tu d'un moment où tu as arrêté ou ralenti l'utilisation de l'application ? Que se passait-il à ce moment-là ?
- Qu'est-ce qui te frustre, même un peu, quand tu l'utilises aujourd'hui ?
- Qu'est-ce qui te donnerait envie de continuer à l'utiliser sur plusieurs mois, voire années ?

Besoins identifiés (synthèse)

ID	Besoin reformulé	Origine
B1	Voir l'évolution de mon traitement dans le temps	Cas réel : changement de dosage (metformine 1000mg -> 500mg)
B2	Être reconnue pour ma régularité, indépendamment de l'évolution médicale	Verbatim : « à quoi bon cocher, ça ne change rien »
B3	Pouvoir personnaliser l'application pour qu'elle me ressemble	Observation IHM (interface jugée basique, non personnalisable)
B4	Un rapport partagé à mon médecin qui soit vraiment utile	Verbatim : « il n'a même pas voulu l'ouvrir » + test réel de l'export CSV
B5	Me sentir moins seule, sans comparaison ni compétition	Verbatim + benchmark Strava
B6	Garder de la valeur même une fois la prise devenue un automatisme	Verbatim : « je le fais presque de mémoire, je n'ouvre plus l'app »
B7	Un rôle pour mon entourage proche, au-delà de la simple alerte d'oubli	Verbatim : « mon copain n'est pas dans l'app »
B8	Pouvoir gérer le traitement d'un proche comme le mien	Cas réel : gestion du traitement d'un parent (aidant)

4. Cahier des charges / spécification fonctionnelle

Contexte et objectif

Refonte du parcours d'engagement d'une application de suivi de traitement chronique, suite au constat que les patients restent observants à leur traitement médical mais désengagent de l'outil numérique après quelques semaines d'usage.

Périmètre

Dans le périmètre

- Fonctionnalités de reconnaissance et de valorisation de l'usage long terme
- Amélioration du rapport partagé avec le corps médical
- Mise en relation communautaire par pathologie
- Historique des ajustements de traitement

Hors périmètre

- Refonte des fonctionnalités de rappel/alarme de base (déjà performantes)
- Télémédecine ou prescription en ligne
- Dashboard dédié aux professionnels de santé (projet ultérieur potentiel)

Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Besoin source	Description
EF01	Historique des ajustements	B1	Frise chronologique des changements de dosage/molécule
EF02	Bilan de régularité valorisant	B2, B6	Vue périodique du taux de régularité, message de reconnaissance non conditionné au résultat médical
EF03	Rapport médecin synthétique	B4	Export PDF d'une page, lisible sans logiciel spécifique
EF04	Groupes de soutien par pathologie	B5, B7	Espace d'échange non compétitif, sans classement
EF05	Rôle proche aidant (consultation)	B7	Un proche voit un résumé de régularité, avec consentement
EF06	Personnalisation de l'interface	B3	Thème visuel et mise en avant d'un traitement prioritaire
EF07	Mode gestion déléguée	B8	Un aidant gère activement le traitement d'un proche

Exigences non fonctionnelles et contraintes

- Confidentialité renforcée pour tout partage de données avec un tiers (RGPD, consentement explicite)
- Simplicité de prise en main maintenue, sans surcharge de menus
- Compatibilité avec le socle fonctionnel existant (rappels, mesures de santé)
- EF04 doit éviter tout mécanisme recréant une pression sociale négative (comparaison, compétition)

5. User stories et critères d'acceptation

US01

En tant que patiente chronique, je veux consulter l'historique des changements de dosage de mon traitement, afin de comprendre l'évolution de ma prise en charge dans le temps.

Critère d'acceptation clé : Un changement de dose archive automatiquement l'ancienne valeur avec sa date de fin ; la frise est consultable sur la fiche du médicament.

US02

En tant que patiente chronique, je veux recevoir un bilan mensuel de ma régularité de suivi, afin de me sentir reconnue pour mes efforts sur la durée.

Critère d'acceptation clé : Le bilan est envoyé chaque fin de mois ; le message de valorisation reste positif même si l'état de santé s'est dégradé sur la période.

US03

En tant que patiente chronique, je veux générer un rapport visuel synthétique de mon suivi, afin de le présenter facilement à mon médecin en consultation.

Critère d'acceptation clé : Le rapport est un PDF d'une page avec graphique de régularité et historique de traitement, lisible sans logiciel spécifique.

US04a / US04b

En tant que patiente, je veux rejoindre un espace d'échange avec d'autres patients de la même pathologie, sans classement ni comparaison de performance, afin de me sentir moins seule sans ressentir de pression.

Critère d'acceptation clé : L'espace n'affiche aucune métrique comparative entre membres ; les réactions restent de type encouragement, jamais compétitives.

US05

En tant que patiente chronique, je veux autoriser un proche à voir un résumé de ma régularité, afin qu'il puisse me soutenir au quotidien au-delà des seuls oublis.

Critère d'acceptation clé : Le patient choisit explicitement ce que le proche peut voir ; le proche n'a pas accès au détail médical (dosages, pathologie).

US06

En tant qu'utilisatrice au long cours, je veux personnaliser l'apparence de mon application, afin qu'elle me ressemble davantage.

Critère d'acceptation clé : Le changement de thème est immédiat ; un traitement prioritaire peut être mis en avant sur l'écran d'accueil.

US07a / US07b

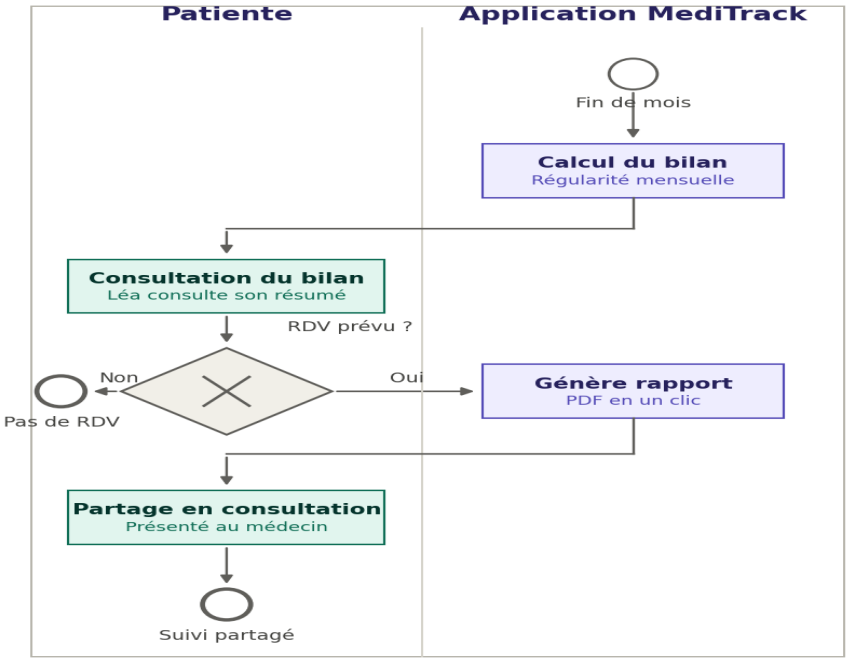
En tant qu'aidant, je veux gérer directement le profil de traitement de mon proche et basculer facilement entre profils, afin de suivre ses prises comme les miennes sans confusion.

Critère d'acceptation clé : Un sélecteur de profil clair évite toute confusion ; un indicateur visuel permanent rappelle quand on n'est pas sur son propre profil.

6. Backlog priorisé (MoSCoW)

Priorité	Stories	Justification
Must have	US01, US02, US03	Traitent la cause racine du désengagement identifiée en entretien
Should have	US05, US06	Forte valeur mais non bloquant ; complexité de permissions à ne pas précipiter
Could have	US04a, US04b	Fort potentiel mais complexité élevée (modération) ; à prototyper avant développement complet
Won't have (itération actuelle)	US07a, US07b	Soulève une question de consentement/responsabilité à cadrer séparément

Diagramme BPMN du processus cible (bilan mensuel)



cercle fin = événement · rectangle = tâche · losange = passerelle exclusive

7. Roadmap de mise en œuvre

Phase	Période	Contenu
Cadrage	Semaines 1-2	Recueil de besoins, cahier des charges, backlog
Release 1 — MVP	Mois 1-2	US01, US02, US03
Release 2	Mois 3	US05, US06
Release 3 — Exploration	Mois 4-5	Prototype et test utilisateur de US04a / US04b
Post-stage / Backlog	Mois 6+	US07a, US07b — nécessite un cadrage juridique complémentaire



Document de travail — à reformuler avec tes propres mots avant intégration finale dans le portfolio, et à enrichir avec les visuels complémentaires (persona illustré, wireframes) si besoin.